

El carnet y el servicio

El año en que Colombia terminó de ganar una batalla y descubrió cuál era la otra

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE), trece rondas 2012–2025.

«Afiliación no es acceso; cobertura formal no es cobertura real.»

Lo escribí hace unos meses en este mismo espacio. Los datos de 2025 me obligan a precisarlo, y la precisión es menos cómoda que la frase.

En 2025, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud llegó al **97,2 %** de la población. Es el máximo histórico. Está 4,1 puntos porcentuales por encima del nivel prepandémico y viene subiendo de forma sostenida: seis décimas por año desde 2018.

En el mismo año, la entrega incompleta de medicamentos formulados llegó al 46,9 %, la espera de más de una hora en urgencias al 36,0 % y la barrera de trámite al 6,5 %. Los tres son máximos del diseño muestral vigente.

Las cuatro cifras salen de la misma encuesta, la misma muestra y el mismo cuestionario. Y esa coexistencia no es una anomalía que haya que explicar. **Es el resultado del año.**

Qué es este balance y de dónde sale

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida es el instrumento con el que el DANE le pregunta cada año a los hogares colombianos cómo viven. En 2025 entrevistó a 235.350 personas. De su capítulo de salud se pueden construir quince indicadores comparables del funcionamiento del sistema: afiliación, salud autopercebida, necesidad de atención no satisfecha, las cinco razones por las que la gente no consulta, entrega de medicamentos, espera en urgencias, percepción de calidad, y tres más.

Dos aclaraciones necesarias antes del balance.

Contra qué se compara. Comparar 2025 contra 2023 haría ver un desplome, porque 2023 todavía estaba en el piso al que bajó el sistema durante la pandemia. El punto de referencia es el promedio de 2018 y 2019: los dos únicos años anteriores a la pandemia que comparten el diseño muestral vigente, y la misma convención que usa el DANE. Es la decisión que más cambia las conclusiones de este tipo de ejercicio, y por eso conviene declararla.

Qué significa que una diferencia «se distinga de cero». Una encuesta estima; no cuenta. El error estándar mide cuánto podría moverse la estimación si se repitiera con otra muestra del mismo tamaño. Cuando una diferencia es varias veces su error estándar, es difícil que sea casualidad. Cuando es del mismo tamaño, lo honesto es decir que no se puede afirmar nada — que no es lo mismo que decir que no cambió.

El balance

De los quince indicadores, trece son comparables contra 2018-2019. Los otros dos —prevalencia de enfermedad crónica y proporción de crónicos con tratamiento— quedan fuera porque en 2023 el DANE cambió el texto de la pregunta y su serie dejó de ser comparable consigo misma.

De esos trece, **cinco tienen una diferencia que se distingue de cero**:

- **Medicamentos formulados no entregados: +12,2 puntos.** El deterioro más grande, y de lejos.
- **Espera de más de una hora en urgencias: +5,6 puntos.**
- **Barrera de trámite o autorización: +2,6 puntos,** y es la única de las cinco razones de no consulta con una tendencia creciente sostenida.
- **Afiliación al SGSSS: +4,1 puntos.** Mejora.
- **Salud autopercibida regular o mala: -3,3 puntos.** Mejora, con una tendencia descendente sostenida desde 2018.

En los ocho restantes la diferencia no se distingue de cero. Conviene insistir en que eso no significa que estén estables: significa que estos datos no permiten afirmar que cambiaron. Con seis rondas anuales, la encuesta detecta escalones grandes y es ciega a movimientos moderados.

Tres deterioros y dos mejoras. Y los tres deterioros están en el mismo lugar.

Antes de seguir, una precisión que un lector exigente va a pedir y que es mejor dar de entrada: los tres deterioros no aguantan lo mismo. Cuando se corrige por comparaciones múltiples —trece contrastes sobre la misma encuesta— y cuando al error estándar se le suma la variabilidad que la serie muestra entre rondas, **solo el de medicamentos sobrevive a las dos exigencias**. La espera en urgencias sobrevive a la segunda y no a la primera. La barrera de trámite no sobrevive a ninguna de las dos como diferencia de nivel, y su fuerza probatoria está en la pendiente, no en el escalón. La lectura honesta del año no es «tres deterioros»: es **un deterioro robusto, uno probable y una tendencia**.

El logro que conviene no minimizar

La afiliación no solo llegó a su máximo. Llegó de forma **equitativa**, y eso es lo que casi nadie está diciendo.

Aquí conviene aplicar el mismo rasero que esta columna le exige a los indicadores adversos, porque si no sería trampa. La diferencia entre quintiles es pequeña en la escala de la afiliación —96,9 % en el más pobre, 98,9 % en el más rico— pero **no es cero**: el contraste da $z = 3,34$ y $p = 0,0008$. Y en la escala complementaria, que es la que le importa a la política, se ve mejor: la no afiliación pasa de 1,1 % en el quintil más rico a 3,1 % en el más pobre, casi tres veces más. Decir «plana» sería exactamente el error que uno le reprocha a la lectura ingenua de cualquier gradiente.

Dicho eso, la magnitud importa y hay que decirla completa. Dos puntos de brecha sobre un nivel del 97,2 % dejan al quintil más pobre por encima de la cobertura poblacional de la mayoría de los países de la OCDE. Y —contra toda expectativa— la afiliación es **mayor en la zona rural que en la cabecera**: 97,7 % frente a 97,1 %. El departamento con menor afiliación está en 92,5 %. La afirmación defendible no es

que no haya gradiente: es que **el gradiente que queda es de otro orden de magnitud** que el de cualquier otro indicador de esta serie.

Un sistema puede tener cobertura casi universal con un sesgo socioeconómico marginal. Colombia la tiene. Es el resultado de treinta años de política deliberada, sostenida a través de gobiernos de signos opuestos, y ningún diagnóstico honesto del sistema debería omitirlo. Quienes defienden el modelo de aseguramiento tienen razón en este punto, y la tienen completa.

La restricción se movió

La distinción que organiza el resto es vieja y está bien establecida en la agenda global de cobertura universal en salud. Se llama la diferencia entre **cobertura de servicios** y **cobertura efectiva**: la primera cuenta a quien tiene derecho al servicio, la segunda a quien obtiene de él el beneficio sanitario esperado.

Un sistema puede maximizar la primera y estancar la segunda. Y los indicadores de afiliación —que son los más fáciles de producir y los más citados— no distinguen entre ambos casos.

Colombia es un caso de manual. La Ley 100 de 1993 organizó el sistema alrededor del aseguramiento y la Ley 1438 de 2011 fijó la universalidad como principio. El país persiguió esa meta tres décadas y la alcanzó. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 ya había desplazado el eje: definió la salud como derecho fundamental y enumeró sus elementos esenciales —disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad—, ninguno de los cuales se satisface con la afiliación. Su artículo 7 ordena al Ministerio publicar una evaluación anual de los indicadores de goce efectivo del derecho.

Diez años después, el indicador que el debate público sigue citando es el de afiliación.

Mientras una parte de la población no tenía carnet, el carnet era el problema. Universalizado el carnet, el problema es lo que el carnet hace. Y lo que el carnet hace se mide en tres lugares muy concretos: el mostrador de la farmacia, la ventanilla de autorización y la sala de espera de urgencias. Es exactamente donde están los tres deterioros.

Dos correcciones al debate público

Primera: la caída de la percepción de calidad es un regreso, no un derrumbe.

El boletín de la encuesta de 2025 destacó la caída de la percepción de calidad frente a 2024, y la caída es real: 2,9 puntos porcentuales, con un contraste que se distingue de cero con holgura. Pero medida contra el nivel prepandémico, la percepción de calidad de 2025 —81,9 %— es indistinguible de la de 2018-2019, que era 81,8 %.

Lo que ocurrió no es que la percepción cayera por debajo de su norma. Es que **subió** durante la pandemia y está regresando. El salto de 2019 a 2020 fue de 6,8 puntos porcentuales, el mayor movimiento interanual de todos los indicadores del sistema, y ocurrió en el año en que la utilización de servicios se desplomó.

La explicación más económica es que la percepción de calidad es una comparación entre lo recibido y lo esperado, y que en 2020 lo esperado bajó más rápido que lo recibido. De ahí se sigue una advertencia práctica: **la percepción de calidad no sirve como indicador de desempeño en un periodo de choque**, porque mide el desempeño relativo a una expectativa que el propio choque desplaza.

Segunda: la mejora de la salud autopercibida no cierra la brecha.

El 12,3 % de los colombianos califica su salud como regular o mala, tres puntos menos que antes de la pandemia, con una tendencia descendente sostenida. La salud autopercibida es uno de los predictores más robustos de mortalidad y uso de servicios que existe en la literatura epidemiológica, así que la mejora no es trivial.

Pero va del 22,2 % en el quintil más pobre al 11,0 % en el más rico. Once puntos de distancia que el promedio nacional no muestra. Que el promedio mejore mientras esa distancia se mantiene es exactamente el patrón que la equidad —añadida como quinta meta al marco internacional de mejora en salud en 2022— fue incorporada para hacer visible.

Lo que estos datos no dicen

No dicen por qué. La encuesta son cortes transversales repetidos, no un panel: muestra cuándo cambia un nivel, nunca la causa. La coincidencia entre el deterioro de la entrega de medicamentos y la situación financiera del aseguramiento en 2024-2025 es una hipótesis a contrastar con fuentes administrativas, no un resultado de este ejercicio.

Lo que sí se sigue del dato es una restricción sobre las explicaciones admisibles. La falla en la entrega de medicamentos **no tiene gradiente socioeconómico**: afecta por igual al quintil más rico y al más pobre, a la ciudad y al campo. Cualquier hipótesis que explique el deterioro por características del usuario —su pobreza, su ruralidad, su nivel educativo— es incompatible con ese hecho.

Todo es autorreporte. La afiliación declarada puede diferir de la afiliación efectiva en la base de datos única. La percepción de calidad y la salud autopercibida responden a expectativas. La entrega de medicamentos depende de la recordación. La independencia respecto del regulado es la virtud de esta fuente; la subjetividad es su costo.

Y hay una meta que no se puede medir aquí. El bienestar del equipo de salud —el personal asistencial— no tiene ninguna variable en una encuesta de hogares. Se declara como vacío en lugar de sustituirse por un indicador de conveniencia.

Cuatro cosas que se siguen de aquí

1. **Cambiar el indicador de titular.** Mientras la afiliación sea la cifra que abre el boletín y el debate, el sistema seguirá siendo evaluado por la dimensión que ya resolvió. La sustitución natural es un conjunto pequeño de indicadores de prestación efectiva —entrega de medicamentos, necesidad no satisfecha por razón, oportunidad—, reportados con su incertidumbre y su gradiente. Es lo que el artículo 7 de la Ley Estatutaria ya ordena publicar cada año.

2. **Reportar siempre el gradiente junto al promedio.** Dos de los indicadores que mejoraron mantienen brechas socioeconómicas de dos dígitos. Un promedio que mejora sobre una distribución que no se cierra es un resultado distinto de una mejora general, y solo el segundo justifica declarar éxito.
3. **Reconocer que la encuesta de hogares es el tercero que el sistema de información no tiene.** El debate sobre el desempeño del sistema se libra hoy entre partes con interés financiero directo sobre lo que reportan. La encuesta no compite con el registro administrativo: lo audita, y alcanza a quien el registro no puede ver por construcción — a quien necesitó atención y no la buscó, y a quien abandonó el tratamiento y por eso dejó de aparecer en los datos.
4. **Publicar el módulo de diseño de todas las rondas.** El DANE publica el estrato y el conglomerado de la muestra solo para 2022, 2024 y 2025. Sin ese módulo nadie puede reproducir los errores estándar de la serie completa, y sin errores estándar correctos las conclusiones cambian de signo. Es una decisión de transparencia de costo nulo.

El cierre

Fui asesor en la ADRES hasta agosto de 2026 y hoy no trabajo en ninguna entidad del sistema de salud, así que invito a contrastar cada cifra con fuentes independientes. Los microdatos son públicos, el procesamiento es reproducible, y la serie completa de afiliación de este ejercicio coincide con la publicada por el DANE en sus boletines, año por año, dentro de cuatro centésimas de punto.

Colombia ganó la batalla del aseguramiento. La ganó de verdad, y la ganó bien: casi universal y con una brecha entre ricos y pobres de dos puntos, cuando el resto de sus indicadores sociales tiene brechas de veinte. Es un logro que le costó tres décadas y que muy pocos países de la región pueden mostrar.

Y ganarla es lo que dejó a la vista la otra.

El carnet se universalizó mientras el servicio se deterioraba. Las dos cosas son ciertas, y la segunda es consecuencia de haber resuelto la primera — no de haberla fallado.

Referencias

- Berwick, D. M., Nolan, T. W., & Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, health, and cost. *Health Affairs*, 27(3), 759-769.
- Bodenheimer, T., & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim. *Annals of Family Medicine*, 12(6), 573-576.
- Congreso de Colombia. (1993). *Ley 100 de 1993*. Bogotá.
- Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1438 de 2011*, artículo 3. Diario Oficial 47.957.
- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículos 6 y 7. Diario Oficial 49.427.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Idler, E. L., & Benyamini, Y. (1997). Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. *Journal of Health and Social Behavior*, 38(1), 21-37.

Ng, M., Fullman, N., Dieleman, J. L., Flaxman, A. D., Murray, C. J. L., & Lim, S. S. (2014). Effective coverage: a metric for monitoring universal health coverage. *PLoS Medicine*, 11(9), e1001730.

Nundy, S., Cooper, L. A., & Mate, K. S. (2022). The Quintuple Aim for health care improvement. *JAMA*, 327(6), 521-522.

Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2023). *Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report*. Ginebra.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones, análisis y reflexiones que publico en este espacio son exclusivamente de mi autoría y de carácter personal. Fui Asesor de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta agosto de 2026; a la fecha de esta publicación no me desempeño en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Nada de lo aquí escrito constituye posición institucional ni representa el criterio oficial de la ADRES, del Ministerio de Salud y Protección Social, ni de ninguna otra entidad del sector.

Los contenidos se elaboran a partir de (i) información de dominio público —en particular los microdatos anonimizados que el DANE publica—, (ii) literatura académica verificable debidamente citada, y (iii) experiencia profesional acumulada a lo largo de mi trayectoria. En ningún caso divulgan información reservada, datos personales de beneficiarios, datos de operación contractual, ni elementos bajo deber de confidencialidad institucional.

Cuando discuto mecanismos de política pública, metodologías técnicas o desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hago en mi calidad de ciudadano y profesional del sector, con el ánimo de aportar al debate público informado. Las propuestas que formulo son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Quien desee la posición oficial de la ADRES sobre cualquier tema puede consultar sus canales institucionales en www.adres.gov.co.

El procesamiento que sustenta las cifras de esta columna es reproducible y está documentado en el documento de trabajo correspondiente de la serie. Esta versión es un borrador sometido a revisión externa: se agradece cualquier corrección.

Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.